

ICD-10 · F3-Spektrum

Gegenseitige Ausschlussdiagnosen – Übersicht und Begründung

Im ICD-10-Kapitel F30–F39 schließen sich zahlreiche Diagnosen gegenseitig aus. Die Ausschlüsse ergeben sich aus dem Schweregrad, der Episodenanzahl, dem Verlaufsmuster oder dem Vorhandensein manischer bzw. psychotischer Merkmale. Diese Übersicht listet alle relevanten Ausschlusspaare und erläutert die jeweilige Begründung.

Zeichenerklärung

E	Beide Diagnosen können grundsätzlich nie gleichzeitig vergeben werden.
R	Die erste Diagnose wird im Krankheitsverlauf durch die zweite ersetzt (Chronologie).
H	Die spezifischere/schwerere Diagnose löst die subklinische Restkategorie ab.

Insgesamt 15 Ausschlusspaare in 6 thematischen Gruppen.

F30 vs. F31 – Einzelne Episode vs. bipolarer Verlauf

F30 darf nur für die allererste manische/hypomanische Episode ohne vorherige affektive Episoden kodiert werden.

#	Diagnose A	■	Diagnose B	Typ	Begründung
1	F30.-	■	F31.-	R	F30 gilt ausschließlich für eine einzelne (erstmalige) manische oder hypomanische Episode ohne frühere affektive Episoden in der Anamnese. Sobald eine zweite affektive Episode (gleich welcher Polarität) auftritt, wird F30 zwingend durch F31 (Bipolare affektive Störung) ersetzt. Beide Codes können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Innerhalb F30 – Schweregradabstufungen

Die Untergruppen F30.0, F30.1 und F30.2 schließen sich gegenseitig aus – es wird immer nur der höchste Schweregrad kodiert.

#	Diagnose A	■	Diagnose B	Typ	Begründung
1	F30.0	■	F30.1	E	Hypomanie (F30.0) und Manie ohne Psychose (F30.1) schließen sich aus: Bei Hypomanie sind Schwere und Funktionsbeeinträchtigung per Definition geringer; es kommt nicht zu einem Abbruch der Berufstätigkeit oder sozialer Ablehnung. Sind diese Kriterien erfüllt, wird F30.1 kodiert.
2	F30.0	■	F30.2	E	Hypomanie (F30.0) ist per Definition frei von Wahn und Halluzinationen. Treten psychotische Symptome auf, schließt das eine Hypomanie-Diagnose aus und erfordert F30.2 (Manie mit psychotischen Symptomen).
3	F30.1	■	F30.2	E	F30.1 (ohne Psychose) und F30.2 (mit Psychose) schließen sich aus. Das Auftreten von Wahn oder Halluzinationen ist das differenzierende Kriterium – es wird immer nur einer der beiden Codes vergeben.

F31 vs. F32/F33 – Bipolar vs. unipolar depressiv

Eine bipolare Vorgeschichte (auch nur eine manische/hypomanische Episode) schließt die unipolaren Depressionsdiagnosen F32 und F33 als Hauptdiagnose aus.

#	Diagnose A	■ Diagnose B	Typ	Begründung
1	F31.-	■ F32.-	R	Eine einzelne depressive Episode (F32) wird nur kodiert, solange keine frühere manische oder hypomanische Episode bekannt ist. Sobald eine solche Episode in der Anamnese vorliegt, wird F32 durch die entsprechende F31-Untergruppe (z. B. F31.3–F31.5) ersetzt.
2	F31.-	■ F33.-	R	F33 (rezidivierende depressive Störung) setzt ausdrücklich das Fehlen jeglicher manischer oder hypomanischer Episoden voraus. Tritt eine solche auf – auch nach Jahren rein depressiver Episoden – wird die Diagnose zwingend auf F31 geändert.

F32 vs. F33 – Einzelne vs. rezidivierende depressive Episode

F32 und F33 können nicht gleichzeitig kodiert werden. Das Unterscheidungsmerkmal ist ausschließlich die Anzahl bisheriger Episoden.

#	Diagnose A	■ Diagnose B	Typ	Begründung
1	F32.-	■ F33.-	E	F32 bezeichnet eine erste oder einzelne depressive Episode; F33 setzt mindestens zwei voneinander unabhängige depressive Episoden voraus. Mit dem Auftreten einer zweiten Episode wird F32 durch F33 ersetzt – eine gleichzeitige Vergabe beider Codes ist nicht zulässig.

F34 – Anhaltende Störungen vs. episodische Diagnosen

F34 (Zyklothymia, Dysthymia) beschreibt subklinische, chronisch-anhaltende Verläufe. Sobald die Schweregrad- oder Episoden-Kriterien der übergeordneten Kategorien erfüllt sind, werden diese kodiert und F34 entfällt.

#	Diagnose A	■ Diagnose B	Typ	Begründung
1	F34.0	■ F30.-	H	Zyklothymia (F34.0) schließt vollwertige manische Episoden aus. Tritt erstmals eine Manie auf, wird F34.0 durch F30 (Einzelepisode) bzw. F31 (bei weiterer Vorgeschichte) ersetzt.
2	F34.0	■ F31.-	H	Zyklothymia erreicht per Definition nicht den Schweregrad einer bipolaren affektiven Störung. Werden die Kriterien für F31 erfüllt, wird F34.0 durch F31 abgelöst. Beide Diagnosen dürfen nicht gleichzeitig kodiert werden.
3	F34.1	■ F32.-	H	Dysthymia (F34.1) ist eine chronische, subklinische depressive Verstimmung ohne eigentliche depressive Episoden. Treten Episoden auf, die den Schweregrad von F32.0 oder höher erreichen, wird F32 kodiert. Eine gleichzeitige Kodierung ist nur in Ausnahmefällen (sog. Double Depression) zulässig und muss klinisch klar begründet sein.
4	F34.1	■ F33.-	H	Dysthymia und rezidivierende depressive Störung schließen sich als alleinige Hauptdiagnose aus: F33 setzt wiederholte Episoden mit Depressionsschwere $\geq$ F32.0 voraus, was die Schwelle der Dysthymia überschreitet. Sobald diese erfüllt ist, wird F33 kodiert.
5	F34.1	■ F30.-/F31.-	E	Dysthymia setzt das vollständige Fehlen manischer oder hypomanischer Episoden voraus. Treten solche auf, ist F34.1 nicht mehr kodierbar; es gelten F30 (Einzelepisode) oder F31 (bipolarer Verlauf).

F38/F39 – Restkategorien

F38 und F39 sind Restkategorien und entfallen, sobald eine spezifischere Diagnose kodierbar ist.

#	Diagnose A	■ Diagnose B	Typ	Begründung
1	F38.0	■ F31.6	E	Eine gemischte affektive Episode (F38.0) wird nur kodiert, wenn keine frühere bipolare Vorgeschichte vorliegt. Ist eine solche bekannt, wird die gemischte Episode als F31.6 (bipolare Störung, gemischte Episode) klassifiziert.
2	F38.1	■ F33.-	H	Rezidivierende kurze depressive Episoden (F38.1) sind zu kurz, um die Mindestdauer-Kriterien für F33 zu erfüllen. Sobald diese Kriterien (Episodendauer, Anzahl) erfüllt sind, wird F33 kodiert; F38.1 entfällt dann.
3	F39	■ F30.–F38.	H	F39 (nicht näher bezeichnete affektive Störung) ist eine reine Auffangdiagnose. Sie darf nicht kodiert werden, wenn eine spezifischere Diagnose aus F30–F38 möglich ist. Sie schließt alle anderen F3-Diagnosen als Hauptdiagnose aus.

Quelle: ICD-10-GM · Kapitel V (F) · F30–F39 Affektive Störungen · Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)